Psychologie de la Prescription

Pr DJELLALI

Faculté de Médecine Béjaia

Principes de la psychologie de la prescription

Présentation du phénomène placebo

On appelle effet placebo « **tout effet thérapeutique attribuable à un médicament, une médication, une exploration, un acte, un geste, mais indépendamment de ses propriétés pharmacologiques ou spécifiques connues.** »(Shapiro, 1997 ; Lemoine,1996)

1.Effet placebo

Les mécanismes décrits dans la survenue du phénomène *placebo* se situent principalement sur deux plans : biologique et psychologique.

- D'une part, la médecine décrit la mise en action de circuits neuronaux dits, **de « la récompense »** (A. Harrington, 1997 ; Wager D. *et al., 2004)* ou **de «la punition »** *(Benedetti F. et al., 2006) ;*

- D'autre part, elle étudie les « facteurs psychiques » impliqués dans le phénomène placebo, comme «les attentes du patient et du médecin, la qualité de la relation médecin-patient, la personnalité du patient».
- Longtemps considéré en Médecine comme synonyme *de « leurre »* ou *« tromperie »,*
- le placebo y a désormais acquis ses lettres de noblesse.

- C’est grâce au secteur de la recherche et des essais cliniques que son usage s’est répandu à grande échelle.
- En effet, le dispositif actuel de cette recherche, impose à toute nouvelle molécule devant être mise sur le marché, d’être comparée **en termes d’efficacité**, soit à **une molécule déjà considérée comme efficace**, soit **à un placebo**.
- Seule, sa supériorité sur le placebo permettra au nouveau produit d’être autorisé à être mis en vente sur le marché.

Effet Nocebo

Terme introduit en 1961 par Walter Kennedy. L'effet psychologique ou physiologique lié à la prise d'une substance inerte n'est pas toujours bénéfique, sous la forme d'un effet placebo, il peut aussi être dommageable pour l'individu, et on parle alors d'effet Nocebo.

Cet effet Nocebo peut prendre la forme **d'effets indésirables**. Le patient, croyant qu'il prend un médicament, est susceptible de recréer, par **suggestion**, les effets indésirables dont il a pu entendre parler auprès de ses amis ou dans les médias, ou qu'il a simplement lu sur la notice.

2.L'observance et ses facteurs

L'observance ou compliance:

- La prescription raisonnée d'un traitement s'appuie sur la considération des effets bénéfiques attendus ainsi que des effets indésirables, dans une perspective éthique du meilleur rapport bénéfices/risques,
- L'observance ou « compliance » désigne, en médecine, « l'obéissance liée à la confiance, la rigueur plus ou moins grande avec laquelle le patient se plie à la prescription du médecin » (Burner, 1990) ;

  elle renvoie à la prise du traitement par le patient dans une acceptation passive qui répond au consentement.

L’adhésion au traitement

- L’adhésion au traitement représenterait la prise réelle du traitement dans un contexte d’acceptation active renvoyant aux notions d’assentiment, d’alliance thérapeutique incluant responsabilité partagée et collaboration efficace (Valente, 2009).

La mauvaise observance

Elle peut être :

- une non-observance : absence totale de prise de médicament ;
- une sous-observance : omissions de prises, arrêt prématuré du traitement ;
- une sur-observance : augmentation des posologies, de la durée du traitement ;
- une observance variable : adaptation au jour le jour du traitement par le patient, comportement qui évoque l'automédication.

Les facteurs de l'observance

- Les facteurs qui influencent l'acceptation et la prise du traitement sont multiples et très divers ; on peut citer :

  – **La considération de la médecine par le sujet** : méfiance, confiance.
  – **La maladie** : sa durée, sa reconnaissance par le patient : le taux de non-observance est d'autant plus important que l'affection est moins ressentie par le patient, qu'elle est chronique. La souffrance psychique est souvent associée à une observance médiocre.
  – **La personnalité** : du refus actif de « l'objecteur absolu » au refus passif avec des oublis répétés qui témoignent d'une certaine ambivalence, sans oublier les non-adhésions par excès en quantité de médicaments ou en durée de traitement qui se rencontrent plus volontiers dans les pathologies addictives et les personnalités anxieuses, obsessionnelles (Valente, 2009).
  – **La qualité de la relation médecin-malade, la confiance dans le prescripteur** ;
  – **Le soutien social, l'entourage familial, une activité professionnelle** sont des facteurs qui apparaissent habituellement associés à une bonne observance.

3.La médication

L’action d’un médicament est due :

– à son activité pharmacologique,

– aux modalités de la prescription et de la relation médecin-malade,

– à l’attitude du malade, à sa croyance en l’efficacité du traitement (Jeammet, 1980).

Parmi les facteurs d’observance liés au médicament intervient la considération de la médication par le patient, considération qui renvoie à de nombreux aspects :

- la nature du traitement et sa classe thérapeutique,

- **la manière dont le médicament est prescrit** : donner des informations sur la maladie, le médicament, semble associé à une meilleure observance ; un traitement complexe (plusieurs médicaments, nombreuses prises) et de longue durée sera plus difficilement suivi de manière conforme à la prescription,

- **l'efficacité, le délai d'action** : la perception rapide d'une sensation de mieux-être prédit une observance de bonne qualité,

- **la tolérance,**

- le **nom du médicament, la forme pharmaceutique, la couleur de la boîte, des comprimés, la rédaction du prospectus d'information avec en particulier le développement de la liste des effets indésirables** (Tarquinio, 2007).

  Le prescripteur doit prendre en compte, en particulier pour les psychotropes, l'image du médicament dans l'esprit du malade et de sa famille (Zarifian, 1995).

Symbolique du médicament

- L'ordonnance est un point d'articulation essentiel dans l'alliance thérapeutique. Comme le démontre la considération de l'effet placebo, l'organisme répond aux effets biochimiques d'un traitement et également à un contenu symbolique (Zarifian, 1995).

- La prescription médicamenteuse signifie que la souffrance est reconnue, qu'il y a légitimité à se soigner ; le médicament à valeur d'échange, d'objet transactionnel ; s'il est au centre de la relation, il faut éviter que le médicament devienne l'unique objet relationnel avec blocage de la relation médecin-malade (Lambert, 1965), ou encore l'enjeu d'échange et l'enjeu de pouvoir entre le médecin et le malade et parfois la famille (Zarifian, 1995).
- Le médicament identifie le statut de malade; c'est une objectivation de la maladie.
- La prescription dénomme la maladie par sa classe chimique, avec le risque de stigmatisation, comme par exemple pour les psychotropes.

Transfert et observance

- Dans la relation médecin-malade, le transfert, phénomène inconscient, exprime l'investissement affectif du patient sur son médecin .
- la qualité de ce transfert influence l'observance:

➢ un transfert positif, avec le sentiment de confiance, moteur thérapeutique, améliore l'observance

➢ alors que le transfert négatif s'exprime souvent par une non-observance des prescriptions, la mise en échec de tout traitement

4.Le consentement et la prise de décision

- LE CONSENTEMENT, donné par un patient à un soignant, pour des soins ou une recherche biomédicale, et la prise de décision thérapeutique questionnent au plan médical, psychologique, social, philosophique, éthique et légal.

- La pratique clinique s'imprègne de ces questionnements et de l'expérience générale pour élaborer une réponse devant chaque situation singulière, unique.

Le consentement

- « Aucun acte médical ni traitement peuvent être pratiqués sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

- Le consentement éclairé du patient, la notion de libre arbitre, l'élaboration du projet de soins en fonction des troubles et de la demande du patient sont des exigences éthiques qui s'imposent à tout médecin (Nuss, 1995).

- **La qualité de l'information donnée est à la base de la qualité du consentement.**

5.La prise de décision

- **La décision médicale**, prise de manière partagée, concerne le patient pour sa santé et met **en jeu la responsabilité du médecin.**

il s'agit de:

  - l'élaboration d'une stratégie thérapeutique,
  - d'une proposition de choix entre différentes possibilités.

- Il est nécessaire de peser les risques et bénéfices liés aux différentes propositions.
- Il s'agit d'une véritable délibération avec le choix des moyens dans l'intérêt du patient, d'un dialogue entre le malade, qui possède des certitudes subjectives, intuitives, souvent alimentées par les nouvelles sources médiatiques, et le médecin dont l'expérience est rationnelle, avec des conceptions vérifiables.

6.L’éducation thérapeutique

- L’éducation thérapeutique du patient doit permettre aux patients **d’acquérir et de conserver les compétences, les aidant à vivre de manière optimale avec leur maladie**.OMS 1998

- Il s’agit d’un processus permanent, intégré dans les soins et centré sur le patient.
- L’éducation thérapeutique implique des activités organisées:
- Sensibilisation,
- Information,
- Apprentissage de l’autogestion et de soutien psychologique, concernant la maladie et le traitement prescrit, les soins, le cadre hospitalier
- les informations organisationnelles et les comportements de santé et de maladie.

- L’éducation thérapeutique vise à aider les patients et leur famille à comprendre la maladie et le traitement, à coopérer avec les soignants, à vivre plus sainement et à maintenir ou améliorer leur qualité de vie.
- Elle vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique.